

TEMA 7.4 • NEFROLOGÍA

Necrosis Tubular Aguda

PERFIL EUNACOM 1.06.1.004
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Conceptos Fundamentales en Nefrología

Insuficiencia Renal: Aguda vs. Crónica

TABLA 7.4.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	IRA	IRC
Definición	< 3 meses	> 3 meses
Reversibilidad	Alta esperanza de reversión	Generalmente irreversible
Objetivo	Tratar y recuperar función	Frenar progresión

Proteinuria — Definiciones

TABLA 7.4.2: CONCEPTO VS VALOR		
CONCEPTO	VALOR	EQUIVALENTE (ÍNDICE P/CR)
Normal	< 300 mg/24h	< 0.3
Proteinuria	> 300 mg/24h	> 0.3
Rango Nefrótico	> 3 g/24h	> 3
Microalbuminuria (nefropatía inicial)	> 30 mg/24h	Índice Alb/Cr > 0.03

> Ventaja del índice P/Cr (o Alb/Cr): **muestra única de orina** (no requiere recolección de 24h).

Síndromes Nefrológicos

TABLA 7.4.3: SÍNDROME VS COMPONENTES CLAVE	
SÍNDROME	COMPONENTES CLAVE
Síndrome Nefrótico	Proteinuria > 3 g/día + Edema + Hipoalbuminemia + Dislipidemia + Lipiduria
Síndrome Nefrítico	Hematuria dismórfica (acantocitos) + HTA + Edema ± IRA
Glomerulonefritis	Inflamación del glomérulo → hematuria dismórfica/acantocitos en sedimento
GNRP (GN Rápidamente Progresiva)	GN + IRA severa (↓ ≥ 50% clearance < 3 meses)
Síndrome Nefrótico Impuro	Nefrótico + elementos nefríticos (HTA, hematuria, IRA)
Síndrome Riñón-Pulmón	GN + compromiso pulmonar (vasculitis, S. Goodpasture, LES severo)

Tipos de Hematuria

TABLA 7.4.4: TIPO VS SIGNIFICADO	
TIPO	SIGNIFICADO
Hematuria dismórfica / Acantocitos	= Glomerulonefritis (origen glomerular)
Hematuria isomórfica	Origen urológico (litiasis, tumor, etc.)

Nefritis Túbulo-Intersticial

- Definición: Inflamación del intersticio renal y túbulos (≠ glomérulo).
- No es una glomerulonefritis.
- Causas: fármacos (AINES, ATB), infecciones.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 65 años hospitalizado en UCI por shock séptico presenta creatinina de 4.2 mg/dL. Hace 3 días tenía creatinina de 1.0. El FeNa es de 4.5% y el sedimento muestra células epiteliales y cilindros granulosos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Necrosis Tubular Aguda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- NTA es la causa más frecuente de IRA de tipo renal.
- Causa más frecuente: isquemia renal (evolución de IRA prerrenal/shock). Segunda: fármacos (aminoglicósidos).
- Clínica bifásica: fase oligúrica inicial seguida de fase poliúrica con pérdida de agua y electrolitos.
- En la fase poliúrica es fundamental reponer agua y electrolitos para no perpetuar la falla renal.
- Diagnóstico: FeNa mayor al 1% (habitualmente mayor al 3%), Na urinario mayor a 20 mEq/L.
- Sedimento urinario: células epiteliales tubulares, cilindros granulosos y cilindros céreos.
- Tratamiento: tratar causa + reponer pérdidas en fase poliúrica + manejo de complicaciones de IRA.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NECROSIS TUBULAR AGUDA)

PREGUNTA 1

Paciente de 65 años hospitalizado en UCI por shock séptico presenta creatinina de 4.2 mg/dL. Hace 3 días tenía creatinina de 1.0. El FeNa es de 4.5% y el sedimento muestra células epiteliales y cilindros granulosos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) IRA prerrenal por shock séptico
- ☐ B) Necrosis tubular aguda por isquemia
- ☐ C) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
- ☐ D) Nefritis intersticial
- ☐ E) IRA postrenal

PREGUNTA 2

Un paciente con necrosis tubular aguda entra en fase poliúrica. ¿Cuál es la complicación más importante a vigilar y prevenir en esta fase?

- ☐ A) Hipercalemia por retención de potasio
- ☐ B) Deshidratación y depleción de electrolitos
- ☐ C) Edema pulmonar agudo por sobrecarga
- ☐ D) Hiponatremia por retención de agua
- ☐ E) Infección urinaria por estasis

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes fármacos es la causa más frecuente de necrosis tubular aguda por nefrotoxicidad?

- ☐ A) Amoxicilina
- ☐ B) Gentamicina
- ☐ C) Ibuprofeno
- ☐ D) Enalapril
- ☐ E) Metformina

RESUMEN: NECROSIS TUBULAR AGUDA

La necrosis tubular aguda (NTA) es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda de tipo renal. Su causa más frecuente es la isquemia renal, habitualmente como evolución de una IRA prerrenal (paciente en shock que progresa a necrosis de los túbulos renales). En segundo lugar están los fármacos, especialmente los aminoglicósidos (gentamicina, estreptomicina). La clínica se caracteriza por una fase oligúrica inicial cuando se destruyen los túbulos, seguida de una fase poliúrica cuando los túbulos se repermeabilizan pero aún no reabsorben bien, perdiendo mucha agua y electrolitos. Es fundamental reponer estas pérdidas para no perpetuar la insuficiencia renal. El diagnóstico se hace con los elementos de IRA renal (FeNa mayor al 1%, habitualmente mayor al 3%, sodio urinario mayor a 20 mEq/L) más el sedimento urinario que muestra células epiteliales tubulares, cilindros granulosos y cilindros céreos. El tratamiento consiste en tratar la causa, reponer agua y electrolitos en la fase poliúrica, y manejar las complicaciones de la IRA.